UE B2 · SEMESTRE 1

Psychométrie — QCM

Cochez les propositions exactes. Une à trois réponses sont justes par question.
Le nombre attendu est précisé. Les corrigés argumentés sont regroupés à la fin.

49 QCM | 13 thèmes | Corrigés à la fin

Fondements et mesure

Q01 **Quelles caractéristiques relèvent du champ de la psychométrie ? (3 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Les traits de personnalité.
- ☐ B. La seule recherche de maladies neurologiques.
- ☐ C. Les connaissances et le langage.
- ☐ D. La valeur morale globale d'une personne.
- ☐ E. Les composantes de la mémoire.

Q02 **Que permet la standardisation d'un test ? (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Définir des consignes communes.
- ☐ B. Encadrer le matériel et la cotation.
- ☐ C. Déterminer la moyenne d'une population de référence.
- ☐ D. Garantir la même performance à chaque participant.
- ☐ E. Supprimer la nécessité d'une interprétation clinique.

Q03 **Un enfant réalise un test cognitif étalonné pour son âge. À quoi sert l'étalonnage ? (1 bonne réponse)** Facile

- ☐ A. Situer ses résultats par rapport à un groupe pertinent.
- ☐ B. Attribuer une cause médicale à chaque difficulté.
- ☐ C. Rendre inutile l'analyse de son profil.
- ☐ D. Remplacer les consignes de passation.
- ☐ E. Décrire toutes ses capacités futures.

Q04 **Quelles affirmations décrivent correctement les tests et leurs limites ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. L'échelle de Binet de 1905 a favorisé leur développement.
- [ ] B. Le classement typologique repose obligatoirement sur un rang numérique.
- [ ] C. Un résultat chiffré est une mesure exhaustive de la personne.
- [ ] D. Une utilisation éducative peut soulever des enjeux sociaux.
- [ ] E. Un test et un examen clinique sont deux démarches équivalentes.

Qualités psychométriques

Q05 **À quelle qualité correspond la reproductibilité d'une mesure dans des conditions comparables ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. La sensibilité aux variations.
- [ ] B. L'étalonnage par âge.
- [ ] C. La validité du construit annoncé.
- [ ] D. La fidélité.
- [ ] E. L'intensité du symptôme.

Q06 **Une échelle annoncée comme une mesure de dépression évalue surtout l'anxiété. Quel problème cela pose-t-il ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Il est démontré que sa fidélité est nulle.
- [ ] B. Une bonne reproductibilité suffirait à résoudre ce problème.
- [ ] C. Cela montre uniquement une mauvaise représentativité de l'échantillon.
- [ ] D. Son adéquation au phénomène ciblé est mise en question.
- [ ] E. Le calcul d'un score rend le résultat valide.

Q07 **Quelles propositions concernant la fidélité sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Elle empêche l'évaluation d'un changement thérapeutique.
- [ ] B. Elle s'apprécie lorsque les conditions et le phénomène restent comparables.
- [ ] C. L'état du sujet doit être considéré lors des comparaisons.
- [ ] D. Elle exige un score identique pendant toute la vie.
- [ ] E. Elle ne garantit pas à elle seule la validité.

Q08 **Une échelle donne presque toujours le même score malgré des niveaux très différents du phénomène étudié. Que faut-il examiner en priorité ? (1 bonne réponse)**

Moyen

- ☐ A. Sa capacité à discriminer les variations pertinentes.
- ☐ B. Une impossibilité de construire des références statistiques.
- ☐ C. La certitude que tous les sujets ont le même trouble.
- ☐ D. Le seul nombre de pages du questionnaire.
- ☐ E. La nécessité d'obtenir un consentement moins détaillé.

Bilan psychologique

Q09 **Quels sont des objectifs d'un bilan psychologique ? (3 bonnes réponses)**

Facile

- ☐ A. Remplacer toutes les observations de l'équipe.
- ☐ B. Évaluer les effets d'une prise en charge.
- ☐ C. Aider à définir les objectifs thérapeutiques.
- ☐ D. Préciser les ressources et vulnérabilités.
- ☐ E. Garantir une prédiction certaine de l'évolution.

Q10 **Que désigne une batterie d'outils psychologiques ? (1 bonne réponse)**

Facile

- ☐ A. Un ensemble organisé d'épreuves complémentaires.
- ☐ B. Une méthode réservée à l'évaluation de la personnalité.
- ☐ C. Une série de questions choisies sans objectif clinique.
- ☐ D. Un score unique sans sous-épreuves.
- ☐ E. Un entretien obligatoirement non directif.

Q11 **L'école demande un bilan pour un enfant. Quelles attitudes sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. Faire dépendre l'interprétation du seul avis scolaire.
- ☐ B. Réaliser exactement trois séances quel que soit son état.
- ☐ C. Rechercher son adhésion autant que possible.
- ☐ D. Expliquer la démarche dans un langage accessible.
- ☐ E. Considérer que la demande extérieure suffit à obtenir sa coopération.

Q12 **Une personne dit qu'elle souffre encore après plusieurs entretiens mais qu'elle éprouve le besoin de poursuivre. Que peut-on en déduire ? (1 bonne réponse)**

Difficile

- ☐ A. La prise en charge est forcément dépourvue d'effet.
- ☐ B. La parole du patient doit être remplacée par une échelle.
- ☐ C. L'évolution doit être appréciée sur plusieurs dimensions.
- ☐ D. Toute mesure de symptômes devient inutile.
- ☐ E. Le pronostic peut être établi avec certitude.

Contexte et entretiens

Q13 **Une personne échange avec aisance mais présente des difficultés à lire et à organiser certaines tâches. Quelles conclusions sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. La qualité de la relation rend l'évaluation cognitive inutile.
- ☐ B. L'aisance relationnelle n'exclut pas des difficultés cognitives.
- ☐ C. Les difficultés sont nécessairement simulées.
- ☐ D. Les attentes et les explications peuvent nécessiter une adaptation.
- ☐ E. Une origine précise est démontrée par ce seul contraste.

Q14 **Quels éléments peuvent limiter la portée des résultats d'un bilan ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. La seule présence de plusieurs instruments.
- ☐ B. Une formation insuffisante à la passation et à l'analyse.
- ☐ C. Une fatigue importante.
- ☐ D. Une compréhension insuffisante des consignes.
- ☐ E. Le recueil du point de vue du patient.

Q15 **Qu'est-ce qui caractérise l'entretien semi-directif ? (1 bonne réponse)**

Facile

- ☐ A. La suggestion systématique des réponses attendues.
- ☐ B. Un guide préparé et une souplesse dans les réponses.
- ☐ C. L'absence de toute organisation préalable.
- ☐ D. Une indication indépendante du langage et des capacités du sujet.
- ☐ E. Des réponses exclusivement limitées à oui ou non.

Q16 **Quelles associations entre type d'entretien et principe sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Directif : obligation de corriger les réponses du patient.
- [ ] B. Semi-directif : aucune place pour une réponse développée.
- [ ] C. Non directif : relances sans imposer le contenu du discours.
- [ ] D. Directif : questions et réponses davantage encadrées.
- [ ] E. Non directif : choix automatique pour tout jeune enfant.

Développement du tout-petit

Q17 **Quels domaines sont illustrés par l'échelle de Brunet-Lézine révisée ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. La seule réussite scolaire.
- [ ] B. Les catégories de personnalité adulte.
- [ ] C. La coordination.
- [ ] D. Le langage et la sociabilité.
- [ ] E. La posture.

Q18 **Que recherche l'évaluation psychomotrice d'un tout-petit ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Un diagnostic fondé sur une acquisition isolée.
- [ ] B. Un calendrier imposant des acquisitions identiques à tous.
- [ ] C. Le remplacement de l'observation par le seul âge chronologique.
- [ ] D. Une observation de compétences adaptées à son développement.
- [ ] E. Un repérage des difficultés permettant une intervention précoce.

Q19 **Quelle utilisation des repères de développement est pertinente ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Relier les acquisitions aux conditions d'observation.
- [ ] B. Compléter certaines observations par des questions aux parents.
- [ ] C. S'affranchir de la formation si l'on connaît le tableau des âges.
- [ ] D. Déclarer une pathologie dès qu'un item n'est pas réussi.
- [ ] E. Appliquer le même matériel à tous les âges sans adaptation.

Fonctionnement intellectuel

Q20 **Quelles associations entre échelles de Wechsler et publics sont correctes ? (3 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. WAIS : adultes.
- ☐ B. WISC : enfants et adolescents.
- ☐ C. WPPSI : âge préscolaire.
- ☐ D. WPPSI, WISC et WAIS : sous-tests identiques.
- ☐ E. WAIS : nourrissons.

Q21 **Quelles propositions distinguent correctement les domaines cognitifs ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. La vitesse de traitement correspond à la durée totale de la consultation.
- ☐ B. Le raisonnement fluide concerne notamment des problèmes nouveaux.
- ☐ C. La mémoire de travail permet de maintenir et d'utiliser temporairement des informations.
- ☐ D. Le domaine visuo-spatial concerne l'organisation des relations spatiales.
- ☐ E. La compréhension verbale se mesure uniquement par une copie de figure.

Q22 **Un bilan montre des performances très différentes selon les domaines. Quelle interprétation est la plus pertinente ? (1 bonne réponse)** Difficile

- ☐ A. Le score global doit remplacer toutes les observations.
- ☐ B. Le calcul d'un résultat dispense d'en préciser les limites.
- ☐ C. Le profil démontre une origine psychique des difficultés.
- ☐ D. Les points forts doivent être exclus de l'analyse.
- ☐ E. Le sens du résultat global doit être apprécié avec les indices.

Q23 **Un enfant allophone doit bénéficier d'une évaluation cognitive. Quelles propositions sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Déduire un niveau intellectuel faible de la seule maîtrise du français.
- ☐ B. Vérifier la pertinence de la population de référence.
- ☐ C. Envisager un outil moins dépendant du langage si la demande le justifie.
- ☐ D. Considérer qu'un matériel non verbal est sans influence culturelle possible.
- ☐ E. Utiliser un test verbal sans examiner la compréhension.

Q24 **Quelles affirmations sur le profil cognitif et la passation sont exactes ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. Un écart de performance suffit à établir une cause génétique.
- ☐ B. Le profil décrit des ressources et des difficultés.
- ☐ C. L'attention du sujet est sans effet sur les tâches.
- ☐ D. Une durée moyenne d'une heure trente interdit toute organisation différente.
- ☐ E. L'organisation doit respecter les règles de l'instrument.

Personnalité et auto-évaluation

Q25 **Qu'est-ce qu'un trait de personnalité ? (1 bonne réponse)**

Facile

- ☐ A. Un symptôme aigu obligatoirement pathologique.
- ☐ B. Un diagnostic obtenu automatiquement par un questionnaire.
- ☐ C. Une caractéristique toujours reconnue comme gênante.
- ☐ D. Une tendance relativement stable à penser, agir ou réagir.
- ☐ E. Une performance limitée à une tâche de mémoire.

Q26 **Quelles caractéristiques concernent le NEO PI-R ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. Il réduit toute la personnalité à un type unique.
- ☐ B. L'ouverture et l'extraversion font partie des dimensions.
- ☐ C. Il comporte six facettes par dimension.
- ☐ D. Il explore cinq grandes dimensions.
- ☐ E. Il constitue une échelle de dépistage cognitif sur 30 points.

Q27 **Quelles affirmations sur l'auto-évaluation et l'insight sont exactes ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- ☐ A. L'auto-évaluation dépend notamment de la compréhension des questions.
- ☐ B. Un insight limité rend nécessairement toute parole mensongère.
- ☐ C. Égosyntonie signifie absence de toute souffrance.
- ☐ D. L'auto-évaluation est indépendante de la présentation de soi.
- ☐ E. Un trait égosyntonique peut entraîner des difficultés relationnelles.

Q28 **Que désigne le MMPI ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Une batterie de développement psychomoteur du nourrisson.
- [ ] B. Un instrument évaluant exclusivement la mémoire.
- [ ] C. Le score global des échelles de Wechsler.
- [ ] D. Un inventaire de personnalité explorant notamment des dimensions psychopathologiques.
- [ ] E. Un outil dispensant de l'entretien clinique.

Méthodes projectives et dessin

Q29 **Quel principe caractérise les méthodes projectives ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. La présentation d'un matériel ambigu appelant une élaboration.
- [ ] B. Un recueil limité à des réponses de fréquence en auto-description.
- [ ] C. L'absence de formation spécifique.
- [ ] D. L'interprétation libre de toute règle de passation.
- [ ] E. Un diagnostic certain à partir d'une réponse inhabituelle.

Q30 **Quelles associations sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. CAT : matériel thématique destiné à l'enfant.
- [ ] B. Rorschach : questionnaire parental sur l'hyperactivité.
- [ ] C. TAT : calcul mental uniquement.
- [ ] D. Patte-Noire : planches et histoires chez l'enfant.
- [ ] E. Rorschach : taches d'encre.

Q31 **Un enfant de cinq ans réalise souvent des dessins de personnages à l'école. Quelles précautions sont pertinentes pour une évaluation par dessin ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Considérer l'influence des exercices scolaires répétés.
- [ ] B. Négliger les consignes parce que le dessin est libre.
- [ ] C. Relier le dessin à l'âge, au contexte et aux échanges associés.
- [ ] D. Conclure directement à un trouble à partir de la taille du personnage.
- [ ] E. Assimiler une belle réalisation à l'absence de toute difficulté.

Q32 **Quelles affirmations sur l'utilisation clinique du dessin sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Les questions après le dessin sont toujours sans intérêt.
- [ ] B. Le dessin de famille peut être complété par des questions.
- [ ] C. La maîtrise du dessin dispense de connaître l'histoire du sujet.
- [ ] D. La consigne de l'arbre de Koch consiste à recopier une figure géométrique.
- [ ] E. Le thème et l'organisation de la feuille peuvent être observés.

Questionnaires et dépression

Q33 **Quelles modalités d'évaluation de la dépression sont correctement associées ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Beck : auto-évaluation.
- [ ] B. GDS : outil destiné à la personne âgée.
- [ ] C. Hamilton : uniquement évaluation par les parents.
- [ ] D. BDI-13 : inventaire de personnalité en cinq dimensions.
- [ ] E. Un score de dépression constitue à lui seul tout le bilan.

Q34 **Un inventaire comporte 13 items cotés chacun de 0 à 3. Quelle est l'étendue possible du score total ? (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. De 0 à 39.
- [ ] B. De 3 à 42.
- [ ] C. De 0 à 30.
- [ ] D. De 1 à 39.
- [ ] E. De 0 à 13.

Q35 **Dans un inventaire à 13 items cotés de 0 à 3, une personne obtient cinq réponses à 2, trois à 1 et cinq à 0. Quelles affirmations sont exactes ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Le total doit être interprété avec la version de l'instrument.
- [ ] B. Le total est de 13 points.
- [ ] C. Le total est de 16 points.
- [ ] D. Une réponse préoccupante peut être ignorée si le total paraît modéré.
- [ ] E. Le total suffit à établir un diagnostic complet.

Q36 Moyen

Quelles dimensions un questionnaire psychologique peut-il explorer ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. L'intégralité du fonctionnement sans autre méthode.
- ☐ B. Les croyances et processus de régulation émotionnelle.
- ☐ C. La cause certaine d'un trouble à partir du seul total.
- ☐ D. L'intensité des manifestations dépressives.
- ☐ E. La qualité de vie ou le désir de changement.

Q37 Difficile

Quelles propositions sur les processus psychologiques sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Un locus externe suffit à identifier un diagnostic psychiatrique.
- ☐ B. Le perfectionnisme est une mesure exclusive de l'intelligence.
- ☐ C. Un facteur salutogène soutient la santé.
- ☐ D. Le locus de contrôle externe et la résignation sont des synonymes exacts.
- ☐ E. La résignation acquise renvoie au sentiment que ses actions ne changent plus l'issue.

Conners et informateurs

Q38 Facile

Que distingue correctement l'auto-évaluation de l'hétéro-évaluation ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une hétéro-évaluation est toujours remplie par un médecin.
- ☐ B. En auto-évaluation, la personne répond sur son fonctionnement.
- ☐ C. L'hétéro-évaluation supprime tous les biais d'observation.
- ☐ D. L'auto-évaluation nécessite une absence totale de symptômes.
- ☐ E. En hétéro-évaluation, le point de vue d'un tiers est recueilli.

Q39 Moyen

Un parent décrit une agitation pendant les devoirs le soir ; le professeur observe une meilleure attention le matin. Quelles démarches sont pertinentes ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Examiner les contextes et les exigences des tâches.
- ☐ B. Écarter l'avis du parent sans autre analyse.
- ☐ C. Croiser les informations de plusieurs informateurs.
- ☐ D. Poser automatiquement un diagnostic à partir de ce désaccord.
- ☐ E. Rechercher l'effet possible de la fatigue.

Q40 **Quelles propositions sur les questionnaires comportementaux et les difficultés psychiques sont exactes ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Un résultat de Conners équivaut à un diagnostic automatique de TDAH.
- [ ] B. Les difficultés externalisées ne sont jamais observables.
- [ ] C. L'anxiété et la dépression illustrent des difficultés internalisées.
- [ ] D. Les versions de Conners peuvent recueillir des points de vue différents.
- [ ] E. La fréquence d'un comportement suffit sans tenir compte de son contexte.

Observation et registres

Q41 **Quelles observations sont décrites de manière factuelle ? (2 bonnes réponses)**

Facile

- [ ] A. Un seul comportement permet de décrire tout le fonctionnement.
- [ ] B. La personne cherche forcément à contrarier l'équipe.
- [ ] C. L'enfant s'est levé quatre fois pendant dix minutes d'exercice.
- [ ] D. L'enfant est insupportable.
- [ ] E. La personne est restée engagée dans l'activité pendant six minutes.

Q42 **Quel peut être l'intérêt d'un registre d'auto-observation ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Garantir que l'observation n'influence jamais le comportement.
- [ ] B. Supprimer les échanges avec le clinicien.
- [ ] C. Repérer les liens entre situations, pensées et émotions.
- [ ] D. Soutenir la participation dans une démarche de psychoéducation.
- [ ] E. Aider la personne à prendre conscience de certaines répétitions.

Q43 **Une personne présente des difficultés à rendre compte de son fonctionnement quotidien. Que peut apporter l'avis de ses proches ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Des observations dans d'autres contextes.
- [ ] B. Des informations complémentaires sur son fonctionnement habituel.
- [ ] C. Un remplacement automatique du travail professionnel.
- [ ] D. Une interprétation nécessairement dépourvue de biais.
- [ ] E. Une raison d'exclure toute expression du sujet.

Neuropsychologie et MMSE

Q44 — Facile

Quelles affirmations décrivent correctement le MMSE ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Son total peut atteindre 30 points.
- [ ] B. Il comporte une exploration de l'orientation.
- [ ] C. Il s'applique sans consignes précises de cotation.
- [ ] D. Il détermine à lui seul la cause d'une difficulté cognitive.
- [ ] E. Il contribue au repérage d'une possible détérioration cognitive.

Q45 — Moyen

Quelles associations entre domaines du MMSE et maximum de points sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Apprentissage : 3 points.
- [ ] B. Attention et calcul : 5 points.
- [ ] C. Orientation : 10 points.
- [ ] D. Langage : 3 points.
- [ ] E. Praxies constructives : 5 points.

Q46 — Moyen

Quelles conditions de passation sont pertinentes pour un repérage cognitif ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Noter l'anxiété, la fatigue et les difficultés de compréhension.
- [ ] B. Interpréter toute hésitation comme une maladie cognitive.
- [ ] C. Prévoir un lieu calme et un temps suffisant.
- [ ] D. Souffler les réponses pour limiter l'anxiété.
- [ ] E. Informer la personne et rester bienveillant.

Q47 — Difficile

Une personne âgée obtient un résultat faible au MMSE et paraît très anxieuse. Quelle conduite est pertinente ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Transmettre le résultat et les conditions de passation à l'équipe.
- [ ] B. Annoncer immédiatement une maladie d'Alzheimer.
- [ ] C. Considérer le résultat faible comme normal du seul fait de l'âge.
- [ ] D. Écarter toute exploration ultérieure puisque l'anxiété est présente.
- [ ] E. Modifier la cotation pour tenir compte intuitivement de l'anxiété.

Approches et collaboration

Q48 Facile

Quelles associations entre approches d'évaluation et questions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Catégorielle et dimensionnelle : démarches incompatibles.
- [ ] B. Dimensionnelle : interdire tout suivi de l'évolution.
- [ ] C. Catégorielle : exclure l'histoire et le contexte.
- [ ] D. Dimensionnelle : apprécier l'intensité d'une dimension.
- [ ] E. Catégorielle : reconnaître un trouble à partir de signes et de critères.

Q49 Moyen

Quelles contributions infirmières sont pertinentes dans une évaluation psychologique ou cognitive ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Utiliser tout outil dès qu'un formulaire est disponible.
- [ ] B. Partager les observations avec les autres professionnels.
- [ ] C. Distinguer les faits observés des interprétations.
- [ ] D. Poser seul un diagnostic sur la base du total obtenu.
- [ ] E. Contribuer au suivi du fonctionnement quotidien.

Corrigés argumentés

Fondements et mesure

Q01 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Les tendances de pensée et de réaction font partie du champ étudié. B — Faux. La psychométrie ne se limite pas aux maladies neurologiques. C — Vrai. Connaissances et langage sont des caractéristiques évaluables. D — Faux. Une performance psychologique ne mesure pas une valeur morale. E — Vrai. La mémoire est une composante cognitive pouvant être évaluée.

Q02 — Réponses : A, B. A — Vrai. Les consignes communes rendent les situations comparables. B — Vrai. Matériel et cotation participent aux conditions standardisées. C — Faux. Les références de population relèvent de l'étalonnage. D — Faux. Des conditions communes n'effacent pas les différences individuelles. E — Faux. Les résultats gardent besoin d'être interprétés.

Q03 — Réponses : A. A — Vrai. Les références permettent un positionnement individuel. B — Faux. Le positionnement statistique n'identifie pas une cause médicale. C — Faux. Les différences entre domaines restent importantes. D — Faux. Étalonnage et consignes correspondent à deux fonctions différentes. E — Faux. Un résultat ne prédit pas l'ensemble du devenir individuel.

Q04 — Réponses : A, D. A — Vrai. Elle constitue un repère majeur dans la diffusion des tests. B — Faux. Il regroupe selon un type plutôt que selon un rang chiffré. C — Faux. Une mesure ne décrit qu'une partie du fonctionnement. D — Vrai. Les décisions d'orientation ont des conséquences individuelles et collectives. E — Faux. Le bilan clinique peut intégrer des tests mais les dépasse.

Qualités psychométriques

Q05 — Réponses : D. A — Faux. Cette sensibilité concerne la finesse de discrimination. B — Faux. L'étalonnage fournit des références de comparaison. C — Faux. La validité concerne l'adéquation de la mesure au phénomène visé. D — Vrai. La fidélité concerne la stabilité et la reproductibilité conditionnelles. E — Faux. L'intensité décrit le phénomène, non la reproductibilité de sa mesure.

Q06 — Réponses : D. A — Faux. La fidélité ne peut pas être déduite de ce seul constat. B — Faux. Une erreur de cible peut être très reproductible. C — Faux. Le problème décrit porte directement sur ce qui est mesuré. D — Vrai. C'est une question de validité de la mesure. E — Faux. Un score chiffré ne garantit pas la validité.

Corrigés argumentés — suite

Q07 — Réponses : B, C, E. A — Faux. Un outil fidèle peut aider à apprécier un changement réel. B — Vrai. Une variation réelle ne doit pas être confondue avec une erreur de mesure. C — Vrai. Fatigue ou anxiété peuvent rendre deux situations différentes. D — Faux. Développement et évolution clinique peuvent modifier les performances. E — Vrai. Une mesure stable peut viser la mauvaise dimension.

Q08 — Réponses : A. A — Vrai. C'est la sensibilité aux variations visée ici. B — Faux. Un étalonnage reste possible même pour un outil peu discriminant. C — Faux. L'uniformité des scores ne prouve pas une uniformité clinique. D — Faux. La longueur ne renseigne pas directement sur la discrimination. E — Faux. Le défaut de discrimination ne modifie pas l'information due à la personne.

Bilan psychologique

Q09 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Les observations restent complémentaires. B — Vrai. Les dimensions évaluées peuvent être suivies dans le temps. C — Vrai. Les résultats peuvent orienter l'accompagnement. D — Vrai. Le bilan cherche à comprendre le fonctionnement global. E — Faux. Le pronostic reste une appréciation incertaine.

Q10 — Réponses : A. A — Vrai. Plusieurs dimensions peuvent ainsi être explorées. B — Faux. Elle peut notamment explorer les capacités cognitives. C — Faux. Le choix doit répondre à une demande et à une méthode. D — Faux. Une batterie associe plusieurs épreuves ou instruments. E — Faux. La batterie ne se réduit pas à un type d'entretien.

Q11 — Réponses : C, D. A — Faux. L'avis scolaire s'intègre à plusieurs sources d'information. B — Faux. Le nombre de rendez-vous n'est pas une règle fixe. C — Vrai. Le sujet doit rester associé à l'évaluation. D — Vrai. Une information adaptée facilite la compréhension et l'adhésion. E — Faux. La coopération ne découle pas automatiquement de la demande.

Q12 — Réponses : C. A — Faux. La persistance de la souffrance ne résume pas l'ensemble des effets. B — Faux. La parole reste une information clinique essentielle. C — Vrai. Soutien, ressources et intensité des difficultés peuvent évoluer différemment. D — Faux. La mesure peut compléter l'appréciation clinique. E — Faux. Cette déclaration ne permet aucune prédiction certaine.

Corrigés argumentés — suite

Contexte et entretiens

Q13 — Réponses : B, D. A — Faux. La relation ne remplace pas l'exploration des difficultés. B — Vrai. Les différents domaines ne se confondent pas. C — Faux. L'aisance dans un domaine ne prouve pas une simulation dans un autre. D — Vrai. L'accompagnement doit tenir compte des capacités réellement évaluées. E — Faux. Le contraste ne suffit pas à établir une cause.

Q14 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Des instruments complémentaires peuvent au contraire enrichir le bilan. B — Vrai. La compétence du professionnel conditionne l'utilisation de l'outil. C — Vrai. La fatigue peut modifier la disponibilité et la performance. D — Vrai. Les réponses peuvent alors ne pas refléter la capacité visée. E — Faux. Ce point de vue est une composante utile de l'évaluation.

Q15 — Réponses : B. A — Faux. Guider le thème ne signifie pas induire les réponses. B — Vrai. Il associe repères d'entretien et liberté d'élaboration. C — Faux. L'entretien semi-directif s'appuie sur une structure. D — Faux. Ces capacités doivent orienter le choix de la méthode. E — Faux. Cette restriction correspond davantage à certaines questions directives.

Q16 — Réponses : C, D. A — Faux. L'entretien recueille les réponses ; il ne vise pas à les remplacer. B — Faux. Le développement est possible dans un cadre guidé. C — Vrai. La parole se développe à partir d'un thème initial. D — Vrai. Le cadre vise des informations précises. E — Faux. Le choix dépend des capacités d'élaboration et de la demande.

Développement du tout-petit

Q17 — Réponses : C, D, E. A — Faux. L'échelle concerne le développement du jeune enfant. B — Faux. Ce n'est pas l'objectif de cette échelle. C — Vrai. Les actions et manipulations d'objets en font partie. D — Vrai. Ces deux domaines complètent la posture et la coordination. E — Vrai. Elle explore notamment les positions et le contrôle du corps.

Q18 — Réponses : D, E. A — Faux. Une acquisition se comprend dans l'ensemble du développement. B — Faux. Les repères ne sont pas des obligations universelles. C — Faux. L'âge donne un repère, mais les acquisitions doivent être observées. D — Vrai. Les tâches doivent être pertinentes pour l'enfant évalué. E — Vrai. Le repérage aide à adapter l'accompagnement.

Corrigés argumentés — suite

Q19 — Réponses : A, B. A — Vrai. Le contexte participe au sens des réponses. B — Vrai. Les modalités peuvent apporter des informations complémentaires. C — Faux. Connaître des repères ne remplace pas la formation à l'outil. D — Faux. Un item isolé ne suffit pas à un diagnostic. E — Faux. Le matériel doit suivre les règles de l'outil et le public concerné.

Fonctionnement intellectuel

Q20 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Les tranches précises dépendent de l'édition utilisée. B — Vrai. Le WISC est une échelle destinée à cette population. C — Vrai. Cette échelle vise les jeunes enfants selon l'édition. D — Faux. Le contenu et l'organisation varient selon les batteries et éditions. E — Faux. La WAIS est destinée à l'adulte.

Q21 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Elle décrit une performance sur certaines tâches standardisées. B — Vrai. Il mobilise la recherche de relations et de règles. C — Vrai. Elle ne se limite pas au stockage de souvenirs anciens. D — Vrai. L'analyse et l'organisation des formes en font partie. E — Faux. Une copie de figure ne constitue pas une mesure verbale.

Q22 — Réponses : E. A — Faux. Les observations restent nécessaires pour comprendre le profil. B — Faux. Calcul et interprétation sont deux opérations différentes. C — Faux. La dispersion ne permet pas de déterminer cette cause. D — Faux. Ressources et difficultés font partie du profil. E — Vrai. Une seule valeur peut mal rendre compte des écarts.

Q23 — Réponses : B, C. A — Faux. Compétence linguistique et niveau cognitif ne se confondent pas. B — Vrai. L'interprétation exige un cadre adapté. C — Vrai. Cela peut limiter certaines difficultés liées à la langue de passation. D — Faux. La familiarité et les apprentissages restent à considérer. E — Faux. Les réponses seraient difficiles à interpréter.

Q24 — Réponses : B, E. A — Faux. Une conclusion étiologique exige d'autres informations. B — Vrai. Il dépasse le seul résultat global. C — Faux. La disponibilité attentionnelle intervient dans la performance. D — Faux. Une moyenne n'est pas une durée maximale universelle. E — Vrai. Les adaptations ne doivent pas dénaturer la passation.

Corrigés argumentés — suite

Personnalité et auto-évaluation

Q25 — Réponses : D. A — Faux. Un trait peut appartenir au fonctionnement habituel non pathologique. B — Faux. Le diagnostic ne découle pas d'un trait isolé. C — Faux. Certains fonctionnements sont vécus comme accordés à soi. D — Vrai. La stabilité est relative, et ne signifie pas immobilité absolue. E — Faux. Le trait renvoie à un mode habituel de fonctionnement.

Q26 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Il décrit plusieurs dimensions et sous-dimensions. B — Vrai. Elles figurent parmi les cinq domaines. C — Vrai. Les facettes précisent les grands domaines. D — Vrai. Il s'appuie sur un modèle dimensionnel de personnalité. E — Faux. Cette présentation correspond au MMSE, pas au NEO PI-R.

Q27 — Réponses : A, E. A — Vrai. Une question incomprise peut modifier la réponse. B — Faux. La difficulté à se reconnaître dans un trouble n'est pas un mensonge. C — Faux. Une souffrance peut exister chez le sujet ou son entourage. D — Faux. La manière de se présenter peut influencer les réponses. E — Vrai. Le vécu d'accord avec soi n'exclut pas le retentissement.

Q28 — Réponses : D. A — Faux. Cette fonction ne correspond pas au MMPI. B — Faux. Il ne s'agit pas d'une échelle de mémoire. C — Faux. Le QIT est un autre indicateur. D — Vrai. L'interprétation dépend de la version et du public. E — Faux. Le questionnaire s'intègre dans une évaluation plus large.

Méthodes projectives et dessin

Q29 — Réponses : A. A — Vrai. La réponse prend forme dans une situation clinique spécifique. B — Faux. Ce principe décrit plutôt certains questionnaires. C — Faux. Ces méthodes nécessitent une formation. D — Faux. Une méthode de passation et d'analyse est nécessaire. E — Faux. Une réponse isolée ne suffit pas à établir un diagnostic.

Q30 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. La version décrite utilise notamment des scènes animalières. B — Faux. Ce type de recueil correspond à une autre famille d'outils. C — Faux. Le TAT utilise des images et des récits. D — Vrai. Le choix des planches et les récits participent à la méthode. E — Vrai. Le matériel sollicite une élaboration à partir de taches.

Corrigés argumentés — suite

Q31 — Réponses : A, C. A — Vrai. La pratique peut modifier la production graphique. B — Faux. Les consignes définissent la situation d'évaluation. C — Vrai. Le dessin fait partie d'un ensemble clinique. D — Faux. Un signe graphique isolé n'est pas diagnostique. E — Faux. Une qualité graphique ne résume pas le fonctionnement psychique.

Q32 — Réponses : B, E. A — Faux. L'entretien associé peut préciser le sens de la production. B — Vrai. Ces échanges enrichissent l'appréciation clinique. C — Faux. L'histoire et le contexte restent nécessaires. D — Faux. Il s'agit d'une production d'arbres selon des consignes. E — Vrai. Ils font partie des éléments descriptifs examinés.

Questionnaires et dépression

Q33 — Réponses : A, B. A — Vrai. La personne répond sur son expérience. B — Vrai. Le sigle désigne la Geriatric Depression Scale. C — Faux. L'échelle citée est une hétéro-évaluation clinique. D — Faux. Il s'agit d'un inventaire de symptômes dépressifs. E — Faux. L'évaluation globale comporte d'autres informations.

Q34 — Réponses : A. A — Vrai. Le maximum est 13 multiplié par 3. B — Faux. Ces bornes ne résultent pas de la cotation annoncée. C — Faux. Cette borne ne correspond pas à la somme décrite. D — Faux. Un total nul est possible si tous les items valent zéro. E — Faux. Cette limite supposerait des items cotés au maximum 1.

Q35 — Réponses : A, B. A — Vrai. Les règles ne se transposent pas automatiquement d'une version à l'autre. B — Vrai. Le calcul est 5 × 2 + 3 × 1 + 5 × 0. C — Faux. Ce résultat ne correspond pas à la somme des réponses. D — Faux. L'attention à une réponse préoccupante ne dépend pas uniquement du total. E — Faux. Les informations cliniques et l'entretien restent nécessaires.

Q36 — Réponses : B, D, E. A — Faux. Une méthode unique n'épuise pas le bilan global. B — Vrai. Des questionnaires peuvent cibler ces processus. C — Faux. Le score ne démontre pas une cause certaine. D — Vrai. L'intensité peut être décrite par une mesure graduée. E — Vrai. Les questionnaires ne se limitent pas à une liste de troubles.

Q37 — Réponses : C, E. A — Faux. Une attribution de contrôle n'est pas à elle seule un diagnostic. B — Faux. Il peut être exploré comme processus impliqué dans différentes difficultés. C — Vrai. Il est distingué d'un facteur participant aux difficultés. D — Faux. Ils sont liés mais ne décrivent pas le même processus. E — Vrai. Elle concerne un sentiment d'impuissance appris.

Corrigés argumentés — suite

Conners et informateurs

Q38 — Réponses : B, E. A — Faux. Le répondant peut aussi être parent, professeur ou autre informateur prévu. B — Vrai. Le répondant est le sujet lui-même. C — Faux. Les attentes et le contexte influencent aussi le tiers. D — Faux. Elle peut concerner une personne présentant des difficultés. E — Vrai. Il décrit ce qu'il peut observer dans un contexte donné.

Q39 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Des conditions différentes peuvent éclairer des réponses différentes. B — Faux. Son observation peut décrire une situation réelle différente. C — Vrai. La comparaison enrichit la compréhension du fonctionnement. D — Faux. Le désaccord ne suffit pas à un diagnostic. E — Vrai. L'heure et la fatigue peuvent modifier les comportements.

Q40 — Réponses : C, D. A — Faux. Le résultat est un élément de la démarche clinique. B — Faux. Elles se manifestent davantage dans les conduites et interactions. C — Vrai. Elles concernent notamment l'expérience psychique interne. D — Vrai. Parent, professeur et jeune peuvent être sollicités selon la version. E — Faux. Le contexte et le retentissement participent à l'évaluation.

Observation et registres

Q41 — Réponses : C, E. A — Faux. L'évaluation demande plusieurs informations. B — Faux. Cette intention supposée n'est pas un fait observé. C — Vrai. Le comportement, la fréquence et la période sont identifiés. D — Faux. Il s'agit d'un jugement global, non d'un relevé précis. E — Vrai. La durée est une mesure descriptive possible.

Q42 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Le fait de s'observer peut lui-même modifier le fonctionnement. B — Faux. Le registre enrichit les échanges plutôt qu'il ne les remplace. C — Vrai. Le relevé organise les informations dans le temps. D — Vrai. Comprendre et observer peut rendre la personne davantage actrice. E — Vrai. L'observation peut participer au travail thérapeutique.

Q43 — Réponses : A, B. A — Vrai. Les proches peuvent connaître des situations non observées au bilan. B — Vrai. Elles peuvent éclairer les variations constatées. C — Faux. L'avis s'intègre à l'analyse multidisciplinaire. D — Faux. Le point de vue d'un proche possède aussi des limites. E — Faux. Sa parole et ses réactions doivent rester considérées.

Corrigés argumentés — suite

Neuropsychologie et MMSE

Q44 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Ce total résulte de plusieurs domaines. B — Vrai. L'orientation temporelle et spatiale fait partie des domaines. C — Faux. Le protocole prévoit des règles de passation et de cotation. D — Faux. La cause nécessite une évaluation plus complète. E — Vrai. Il s'agit d'un outil de dépistage.

Q45 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. L'enregistrement initial de trois éléments est coté sur 3. B — Vrai. Cette partie contribue pour 5 points au total. C — Vrai. Elle comprend les repères temporels et spatiaux. D — Faux. Le langage est coté sur 8 dans la version présentée. E — Faux. La copie de figure est cotée sur 1.

Q46 — Réponses : A, C, E. A — Vrai. Ces éléments éclairent l'interprétation. B — Faux. Une hésitation peut avoir plusieurs explications. C — Vrai. Cela aide à obtenir des réponses dans de bonnes conditions. D — Faux. L'aide aux réponses modifierait la tâche évaluée. E — Vrai. La relation soutient la participation sans remplacer la standardisation.

Q47 — Réponses : A. A — Vrai. Le score doit être remis dans son contexte clinique. B — Faux. Un score isolé ne suffit pas à ce diagnostic. C — Faux. L'âge ne permet pas cette conclusion automatique. D — Faux. L'anxiété n'exclut pas une autre difficulté. E — Faux. Les règles ne doivent pas être changées arbitrairement.

Approches et collaboration

Q48 — Réponses : D, E. A — Faux. Elles peuvent être complémentaires. B — Faux. Les mesures graduées peuvent au contraire servir au suivi. C — Faux. Ces informations restent indispensables au raisonnement. D — Vrai. Elle permet une description graduée. E — Vrai. Elle organise la réflexion en catégories diagnostiques.

Q49 — Réponses : B, C, E. A — Faux. La disponibilité ne remplace pas la formation et le cadre d'utilisation. B — Vrai. Les compétences et les contextes observés sont complémentaires. C — Vrai. Cette distinction rend les transmissions plus précises. D — Faux. Le score s'intègre à une analyse clinique plus large. E — Vrai. Les observations dans le temps enrichissent le bilan et le projet de soin.